



MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:
PR-JE-04

Versión vigente:
01

Fecha de emisión:
10 DIC 2020

Fecha de revisión:
10 DIC 2022

1. OBJETIVO.

Disminuir la probabilidad de que ocurran eventos adversos y centinela relacionado con la realización incorrecta de un procedimiento quirúrgico o procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano, por medio de la aplicación del Protocolo Universal.

2. ALCANCE

Este proceso tendrá inicio en el momento que sea necesario el abordaje de procedimientos quirúrgicos que se realicen en la sala de operaciones y los que se realicen fuera de ella, así como en los procedimientos y tratamientos invasivos y de alto riesgo, se considera al término de la cirugía, con el paciente en sala de recuperación, el fin de este proceso.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Actualización: Jefatura de enfermería.

3.2 Ejecución: Equipo multidisciplinario.

3.3 Supervisión: Dirección Médica.

4. DESARROLLO DE PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Médico cirujano, tratante o médico de guardia.	PACIENTE HOSPITALIZADO Realiza la indicación de procedimiento quirúrgico o invasivo a paciente, acorde a la previa valoración.
2		Informa a paciente y familiar las acciones a seguir de tratamiento.
3		Realiza solicitudes de estudios de laboratorio, radiográficos o cualquier auxiliar diagnóstico que se requiera en el procedimiento del paciente.

MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:

PR-JE-04

Versión vigente:

01

Fecha de emisión:

10 DIC 2020

Fecha de revisión:

10 DIC 2022

4		De acuerdo a PR-JE-02 MISP 2. proceso para mejorar la comunicación efectiva a enfermería, el procedimiento invasivo a seguir, así como día y hora para poder realizar la programación.
5		En este momento se inicia con la activación del: “PROTOCOLO UNIVERSAL”
6	Médico cirujano, tratante o médico de guardia /Enfermería	Se comunica con “quirófano” y verifica disponibilidad, si así es programa hora y fecha.
7	Enfermería	Al programar procedimiento, se verificará nombre del paciente, fecha de nacimientos, PAC, procedimiento a seguir, médico cirujano y/o tratante.
8		Al realizar cambio de turno, se notifica al turno entrante el procedimiento programado, fecha y hora.
9		Día previo, se iniciará con la preparación del paciente para el procedimiento invasivo o quirúrgico, valorando los requerimientos como baño, estudios de gabinete, solicitud de ayuno, o cualquier auxiliar diagnóstico que sea requerido para el procedimiento.
10		Se comunica con área de admisión y solicita los formatos de consentimiento informado. (paciente adulto) (Paciente menor o con deterioro neurológico).
11		Los formatos de consentimiento informado se solicitarán el día en que se realiza la cirugía o procedimiento programado, con antelación a la hora del procedimiento, siendo este día su única utilidad, en caso de reagendar fecha de cirugía, se tendrá que solicitar nuevos consentimientos informados el día agendado.
12		Comenzará con el llenado de la hoja de “Verificación del procedimiento quirúrgico seguro del paciente”
		Se educara al paciente y/o familiar el manejo del proceso quirúrgico por el cual será sometido, explicando en que consiste el protocolo universal y el tiempo fuera, y que se requiere de su participación para la toma de decisiones.

MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:

PR-JE-04

Versión vigente:

01

Fecha de emisión:

10 DIC 2020

Fecha de revisión:

10 DIC 2022

13	Médico cirujano, tratante o médico de guardia.	Informará al paciente los detalles de su procedimiento o cirugía y aclarará cualquier duda que presente.
14		Entregará los consentimientos informados para ser firmados por el paciente o representante legal.
15		Solicitará en tiempo al paciente para ser trasladado al área de quirófano o al lugar donde se realice el procedimiento.
16		Se han identificado áreas donde se realizará el “Protocolo Universal” como lo son: Quirófano Hemodiálisis Sala Endoscopias Y algunos procedimientos invasivos: Transfusión de sangre y hemoderivados Terapia de reemplazo renal Procedimientos quirúrgicos Tomas de biopsia Colocación y/o retiro de dispositivos (sondas pleurales, urinarias, catéteres, dispositivos intrauterinos, catéteres) Estudios de gabinete que requieren medios de contraste. Colocación de accesos vasculares.
17	Enfermería	Al momento que sea solicitado el paciente para cirugía o procedimiento, la enfermera a cargo del paciente habrá verificado que este completa la documentación requerida del paciente: Consentimientos informados Estudios laboratoriales Estudios radiológicos O estudios que sean relevantes debidamente identificados
18		Comunicará con el servicio de camellería para trasladar a paciente, aplicando PR-JE-02, MISP 2. proceso para mejorar la comunicación efectiva informando los requerimientos de traslado del paciente (oxígeno, camilla, silla de ruedas)
19	Camellería	Atenderá oportunamente la orden de traslado de paciente aplicando el PR-JE-06, MISP 6 Reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas.

MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:
PR-JE-04

Versión vigente:
01

Fecha de emisión:
10 DIC 2020

Fecha de revisión:
10 DIC 2022

20		Se continúa el traslado del paciente al área designada para su procedimiento en tiempo y forma requeridos.
21	Enfermería	Enfermera a cargo de paciente se traslada junto al paciente, para hacer entrega a enfermera de quirófano, llevando consigo expediente clínico del paciente y toda la documentación requerida.
22		Entrega paciente a enfermera de quirófano, aplicando el <i>PR-JE-02, MISP 2. proceso para mejorar la comunicación efectiva</i> y entrega documentación requerida, a su vez indica cualquier condición especial que se pudiera presentar en el paciente.
23		Enfermera de quirófano recibe paciente aplicando <i>PR-JE-01, MISP 1. identificación correcta del paciente</i> y <i>PR-JE-02, MISP 2. proceso para mejorar la comunicación efectiva</i> revisa que se entregue documentación requerida.
24		Instala paciente en recuperación y comienza a abrir <i>FT-JE-13 hoja de enfermería de quirófano</i> la cual cuenta con los apartados:
25	Médico cirujano, tratante o médico de guardia.	MARCAJE DEL SITIO QUIRÚRGICO. El marcado debe realizarse sobre la piel del paciente y de manera que permanezca después de la asepsia y antisepsia, se realizara en el área de recuperación utilizando el marcador quirúrgico estándar.
		Debe hacerse de preferencia con el paciente despierto y consciente de preferencia y de ser posible, y ser visible una vez que el paciente esté preparado y cubierto.
26		El marcaje se realizará en presencia de un familiar en el caso de que el paciente no se encuentre consciente, sea menor de edad o que tenga alguna discapacidad. (En caso de ser necesario el marcaje se habrá realizado desde la habitación, siendo este verificado en recuperación)
27		Previo al ingreso a la sala de cirugía, el cirujano responsable de la atención debe marcar el sitio quirúrgico (pudiendo delegar a un médico de guardia o enfermera a cargo, siempre con supervisión)

MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:

PR-JE-04

Versión vigente:

01

Fecha de emisión:

10 DIC 2020

Fecha de revisión:

10 DIC 2022

28		Se marcará el sitio anatómico utilizando un punto (▪) o una letra equis o tache (X), realizando un círculo alrededor:  
29		Cuando la cirugía se realice en órganos bilaterales o estructuras que contengan niveles múltiples.
30		Estará permitido realizar el marcaje documental cuando el procedimiento sea en mucosas o sitios anatómicos difíciles o unilateridad, en procedimientos dentales, recién nacidos prematuros o cuando el paciente no acepte que se marque la piel.
31		Se puede omitir en situaciones de urgencias y en lesiones visibles, como las fracturas expuestas o tumoraciones evidentes.
32	Enfermería	Registrará en <i>FT-JE-13 hoja de enfermería de quirófano</i> cada uno de las pautas anteriores marcando los campos “sí” y “no” respectivamente y llenando las observaciones, en caso de que se omita alguna acción deberá de recordar al médico cirujano de su omisión.
33		VERIFICACIÓN PRE PROCEDIMIENTO La enfermera circulante será la encargada de llenar la <i>FT-JE-13 hoja de enfermería de quirófano</i> en la sección de “cirugía segura (lista de verificación)” marcará cada una de las casillas que correspondan y en caso de omitir alguna esta deberá hacerla saber al equipo quirúrgico.
34	Anestesiólogo, Médico cirujano y Enfermería	ENTRADA Antes de la inducción de la anestesia. Confirman verbalmente con el paciente (si es posible), su identidad preguntando nombre completo y fecha de nacimiento y PAC (según <i>PR-JE-01 MISP 1 Identificación correcta del paciente</i>) el sitio quirúrgico, el procedimiento quirúrgico y su consentimiento.

MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:
PR-JE-04

Versión vigente:
01

Fecha de emisión:
10 DIC 2020

Fecha de revisión:
10 DIC 2022

35	Anestesiólogo/ Médico Cirujano	Confirmar con el cirujano el marcaje del sitio quirúrgico.
36	Anestesiólogo	Realizar el control de la seguridad de la anestesia al revisar: medicamentos, funcionalidad y condiciones óptimas del equipo, así como el riesgo anestésico del paciente.
37		Colocar y comprobar que funcione el oxímetro de pulso correctamente.
38		Confirmar si el paciente tiene alergias conocidas, vía aérea difícil y riesgo de aspiración. En el caso de que sí exista este riesgo, debe verificar que cuente con el material, equipo y ayuda disponibles.
39		Conocer el riesgo de hemorragias: en adultos, mayor a 500 ml y en niños, mayor a 7 ml/kg.
40		Prever la disponibilidad de soluciones parenterales y dos vías centrales.
41		Identificar la necesidad de hemoderivados y, en su caso, verificar que se haya realizado el cruce de sangre previamente.
42		Participar en la prevención de eventos críticos informando la existencia o riesgo de enfermedad en el paciente que pueda complicar la cirugía.
43	Médico cirujano	Confirmar la realización de asepsia en el sitio quirúrgico.
44		Disponibilidad de todos los documentos, imágenes y estudios relevantes, y que estén debidamente identificados.
45		Disponibilidad de los productos sanguíneos necesarios.
46		Funcionamiento adecuado de implantes, dispositivos y/o equipo especial necesarios.
47		PAUSA QUIRÚRGICA Antes de la incisión: Confirmar que cada uno de los miembros del equipo quirúrgico se haya presentado por su nombre y función (sin omisiones). Los miembros del equipo quirúrgico pueden ser cirujano, anestesiólogo, ayudante de cirujano, enfermera quirúrgica, enfermera circulante.

MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:
PR-JE-04

Versión vigente:
01

Fecha de emisión:
10 DIC 2020

Fecha de revisión:
10 DIC 2022

48	Médico cirujano	Confirmar la realización de asepsia en el sitio quirúrgico.
49		Verificar que se cuenta con los estudios de imagen que se requieren.
50		Participar en la prevención de eventos críticos informando los pasos críticos o no sistematizados, la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista.
51		Verificar que se haya aplicado la profilaxis antibiótica conforme a las indicaciones médicas, si procede.
52		Participar en la prevención de eventos críticos, informando la fecha y método de esterilización del equipo e instrumental.
53	Enfermería	Informar si hubo algún problema con el instrumental, equipos y material, así como con el conteo del mismo.
54	Médico cirujano	SALIDA Antes de que el paciente salga del quirófano En presencia del anestesiólogo y el personal de enfermería, confirmar que se ha aplicado la lista de verificación de cirugía segura. Debe confirmar verbalmente: - El nombre del procedimiento realizado. - El recuento completo del instrumental, gasas y agujas. - El etiquetado de las muestras (nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, fecha de la cirugía y descripción general de la muestra). - Si hay problemas que resolver, relacionados con el instrumental y los equipos que deben ser notificados y resueltos.
55		Reportar si ocurrieron eventos adversos y en caso afirmativo registrarlos.
56	Anestesiólogo, Médico cirujano y Enfermería	Comentar al circulante los principales aspectos de la recuperación postoperatoria, el plan de tratamiento y los riesgos del paciente.
57	Enfermería	Verificar que todos los integrantes del equipo quirúrgico deben anotar su nombre y firmar la lista de verificación de cirugía segura, en la parte que les corresponde.
58		La lista de verificación de cirugía segura debidamente llenada y firmada por todos los integrantes del equipo quirúrgico, debe integrarse al expediente clínico del paciente.

MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:

PR-JE-04

Versión vigente:

01

Fecha de emisión:

10 DIC 2020

Fecha de revisión:

10 DIC 2022

59		En el caso de terapia de reemplazo renal con hemodiálisis verificar: a) Paciente correcto b) Procedimiento correcto c) Disponibilidad de todos los documentos y estudios relevantes y que estén debidamente identificados. d) La presencia o funcionamiento adecuado de todos los equipos y/o dispositivos médicos necesarios. e) Las alergias del paciente. f) El filtro correcto g) La identificación del acceso vascular.
60	Enfermería / personal banco de sangres	En el caso de transfusión de sangre y hemocomponentes: ver <i>PR-BS-03 proceso de Hemotransfusión</i>
61	Equipo multidisciplinario	TIEMPO FUERA O TIME OUT Con el propósito de llevar a cabo el procedimiento/tratamiento correcto, con el paciente correcto y en el sitio correcto o cualquier otra variable que ponga en riesgo la seguridad del paciente, debe realizarse justo antes de iniciar, al menos, los siguientes procedimientos: • Transfusión de sangre y hemocomponentes (tomando en cuenta, al menos, las siguientes variables: paciente, procedimientos, acceso vascular, grupo y Rh y hemocomponente correcto). • Terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, (tomando en cuenta, al menos, las siguientes variables, procedimientos, paciente, prescripción dialítica, filtro correcto (si se tienen contemplado y autorizado el re-uso) evaluación del sangrado activo y valoración del acceso vascular). • Toma de biopsia. • Colocación/retiro de dispositivos (sondas pleurales, urinarias, catéteres, dispositivos intrauterinos, catéteres para hemodiálisis, entre otros). • Estudios de gabinete que requieren medios de contraste. • Colocación y manejo de accesos vasculares.
62		
63	Médico cirujano	Responsable de la atención debe: • Confirmar que es el paciente correcto, procedimiento correcto, sitio quirúrgico correcto, en caso de órgano bilateral, marcaje derecho o izquierdo, según corresponda, en caso de estructura múltiple especificar el nivel a operar y la posición correcta del paciente. • Verificar que se cuenta con los estudios de imagen que se requieren. • Prever eventos críticos, verificando la fecha y método de esterilización del equipo e instrumental. • Promover que el paciente y/o cuidador reciban información completa y fácilmente comprensible sobre su proceso asistencial y los riesgos que conlleva.

MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:

PR-JE-04

Versión vigente:

01

Fecha de emisión:

10 DIC 2020

Fecha de revisión:

10 DIC 2022

	Equipo multidisciplinario.	Finalizado el procedimiento, el paciente será enviado a la sala de recuperación, considerando este momento el fin del proceso.
64	Médico cirujano o tratante	PACIENTE AMBULATORIO Programa fechas de cirugía, informa al paciente los requerimientos necesarios para el procedimiento a realizar.
65	Admisión	Al arribo de paciente ambulatorio se generan la papelería necesaria (consentimientos informados)
66		Se traslada a quirófano, entrega documentación y presenta paciente a enfermería.
67	Enfermería	Recibe paciente y comienza con el inciso 23 de este proceso.
68	Enfermería	Para valorar el cumplimiento de este proceso se contemplan los formatos de consentimiento informado y la Hoja de Verificación del procedimiento quirúrgico seguro del paciente, así como la hoja de enfermería de quirófano, ya que en ellos se indica si el proceso es correcto o no, en caso de no serlo, el proceso como tal no se puede llevar a cabo, teniendo que realizar el inciso que se ha omitido para poder continuar. Se llevara un registro de pacientes que ingresan a procedimiento quirúrgico o invasivo, en cual se anotara los datos del paciente: NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO PROCEDIMIENTO CONSENTIMIENTOS INFORMADOS MARCAJE DE SITIO VERIFICACION PRE- PROCEDIMIENTO TIEMPO FUERA
69	Jefatura de Enfermería	En base a los datos obtenidos se realizara un análisis y se obtendrán porcentajes de cumplimiento de la meta, de acuerdo a estos resultados se valora y se reforzara el cumplimiento en caso de ser requerido.
		FIN DE PROCESO

Código:

PR-JE-04

Versión vigente:

01

Fecha de emisión:

10 DIC 2020

Fecha de revisión:

10 DIC 2022

5. GESTION DE RIESGOS

5.1 Ponderación de riesgos

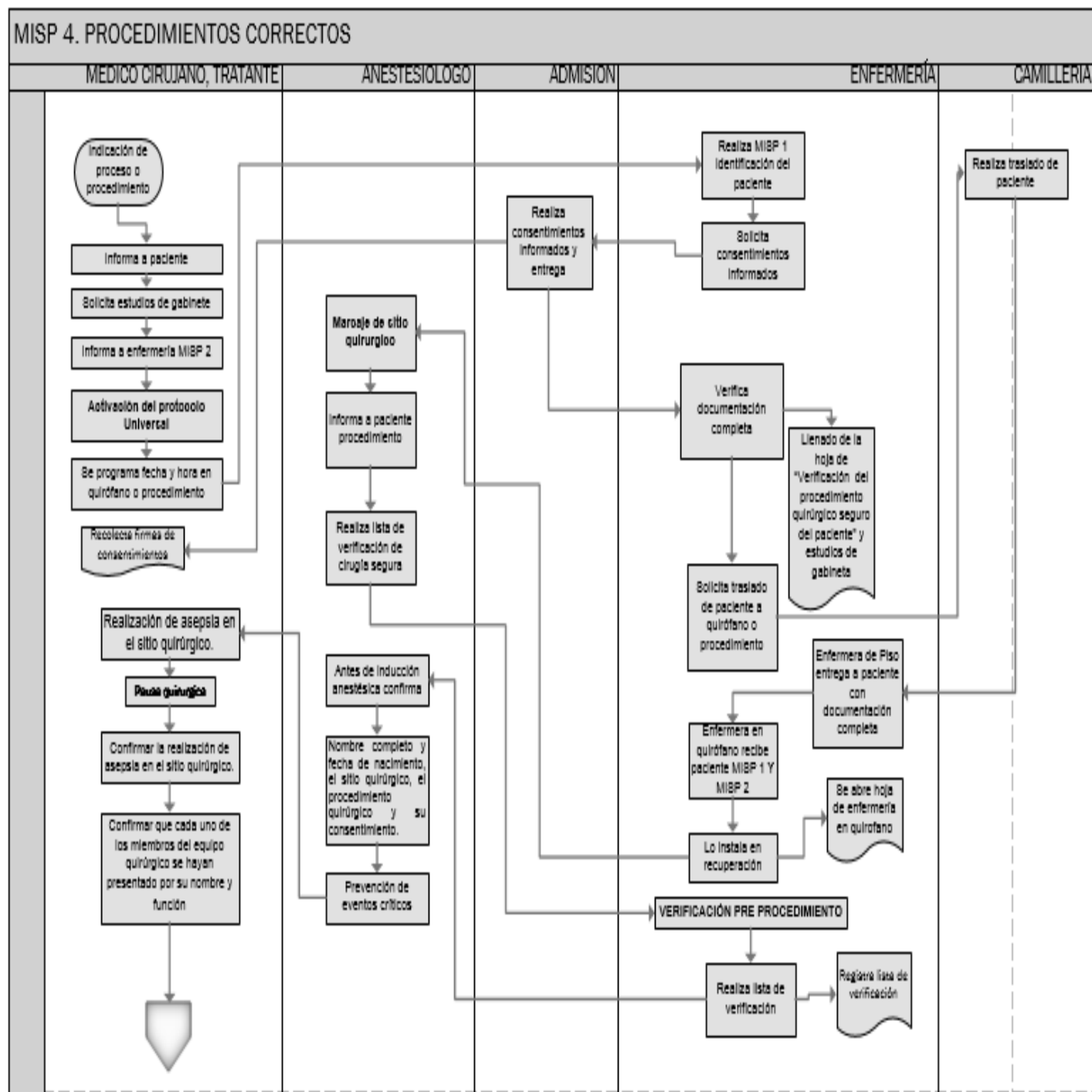
- a) Desconocimiento del proceso patológico del paciente.
- b) Mala comunicación entre el equipo interdisciplinario.
- c) Omisión del protocolo universal o alguno de sus componentes.
- d) No involucrar al paciente o familiar en el marcado del sitio quirúrgico.

5.2 Barreras de seguridad

- a) Mantenerse informado a cerca de la condición clínica del paciente verificando expediente clínico y estudios de gabinete realizados
- b) Fomentar un apego a los procesos hospitalarios, haciendo énfasis en la aplicación de las metas internacionales
- c) Difundir los procedimientos al personal en general, poniendo énfasis en los más involucrados en los procesos quirúrgicos
- d) Mantener al familiar informado y orientarlo sobre el proceso de protocolo universal de este hospital.

6. ANEXOS

6.1 Diagrama de flujo



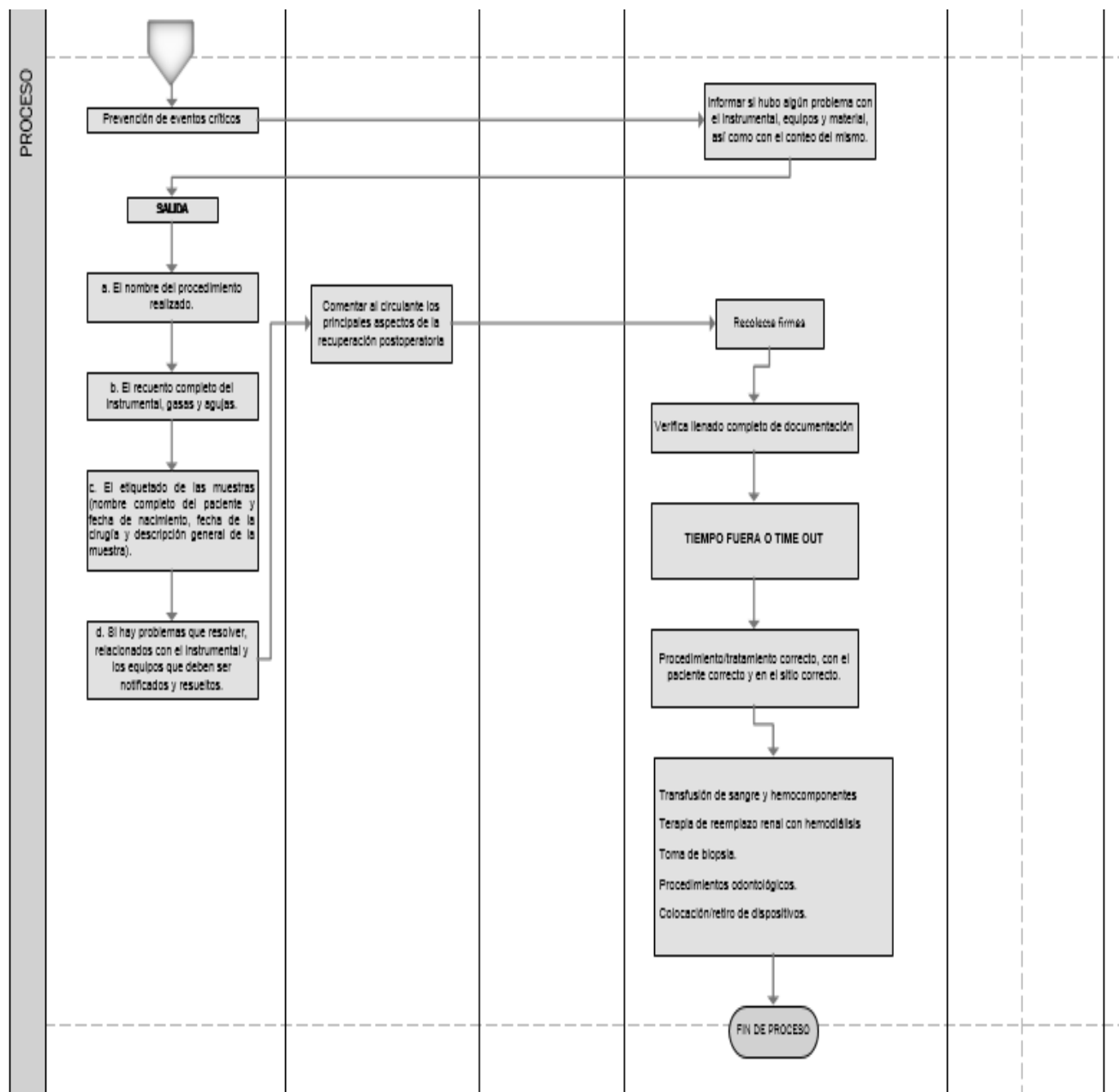
MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:
PR-JE-04

Versión vigente:
01

Fecha de emisión:
10 DIC 2020

Fecha de revisión:
10 DIC 2022





MISP 4. PROCEDIMIENTOS CORRECTOS

Código:
PR-JE-04

Versión vigente:
01

Fecha de emisión:
10 DIC 2020

Fecha de revisión:
10 DIC 2022

6.2 Documentos de referencia

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Hoja de enfermería en quirófano	FT-JE-13
Hoja de verificación del procedimiento quirúrgico seguro del paciente	FT-AD-04
Proceso de Hemotransfusión	PR-BS-03
Formatos de consentimiento informado	
Alianza mundial para la seguridad de la paciente lista oms de verificación de la seguridad de la cirugía manual de aplicación (1ª edición)	

7. CONTROL DE CAMBIOS.

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
1	10/12/20	Alta de documento	Lic. Enf. Gerardo Toledo casas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
2				
3				

8. AUTORIZACIONES.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Enf. Gerardo Toledo Casas.	Lic. Enf. Felicitas Mariela Vargas Román	Dr. José Gonzalo Vázquez Camacho
JEFATURA DE ENSEÑANZA	DIRECCIÓN MEDICA	DIRECCIÓN MEDICA